

Paikkonna tervisedendus pärast reformi



Triinu Purru

Tervise Arengu Instituut

Tänapäevase arusaama kohaselt on tervis täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Olulisem osa tervise ja heaolu edenduseks vajalikke tegevusi leiab aset lisaks laialt levinud liikumissarjadele hoopis teistes valdkondades. Näiteks aitab heaolu kujunemisele kaasa inimeste vajadusi arvestav ühistranspordi korraldus; linnaruumi planeerimine viisil, mis hõlbustab kõigi elanike liikumist ja on turvaline (nt madalad äärekiivid, erivajadustega arvestamine, kergliiklusteede võrgustik, tänavavalgustus, korrastatud rohealad jne); ettevõtluskeskkonna elavdamine selliselt, et tökohad oleksid elanikkonnale sobivad (arvestaksid haridustaset, vanuselist jaotust jne); kultuuri- ja kogukonnaelu toetamine, et suureneks sidusus elanike vahel ning valmisolek ühisesse heaollu panustada (nt kaasav elarve; teenuste ja vastutuse delegeerimine kodanikeühendustele; huviringidele sobilike ruumide pakkumine jne). Mida suurem on inimese heaolu, seda suurem on tõenäosus, et ta on aktiivne kogukonna liige ning seda rohkem loob ta kohalikule kogukonnale kasu.

Eelnevat kokku võttes on tervise ja heaolu edendus süsteemne lähenemine. Sotsiaalseid ja poliitilisi protsesse mõjutades on võimalik saavutada positiivseid muutusi inimeste elukeskkonnas.

Paikkonna tervisedendus enne ja pärast 2017. aastat

Riigi tasandil juhib tervisedendust

sotsiaalministeerium koos oma partneri Tervise Arengu Instituudiga. Kui sotsiaalministeerium loob eelkõige laiema arenguraami seadusandluse ja rahvastiku tervise arengukavaga ning rahastab tegevusi, siis Tervise Arengu Instituut panustab teadustöösse, rakendab tõenduspõhiseid sekkumisprogramme (näiteks vanemlusprogramm „Imelised aastad”); viib läbi kampaaniaid, koostab juhendmaterjale ja loob veebilehti (näiteks „Alkoholipoliitika juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele” või veebileht www.tarkvanem.ee); korraldab koolitusi, arendab ja koordineerib mitmesuguseid võrgustikke (näiteks tervist edendavate koolide, lasteaedade ja töökohtade võrgustikud).

Kuna inimese tervislik seisund ja heaolu kujuneb keskkonnas, kus ta iga päev elab, õpib või töötab, siis kõige paremini saab selleks vajalikke tingimusi luua paikkondliku tervisedenduse kaudu.

Aastatel 1995–2017 koordineerisid paikkonna tervisedendust maavalitsused. 2000ndatel moodustati nende juurde teemanõukogud. 2005. aastaks koondati need maakondlikeks tervisenõukogudeks, mis tervisedendaja eestvedamisel kavakindlalt arendasid valdkonda koos eri valdkondade spetsialistide, KOVide ja võrgustikega. Kui riigireformi käigus maavalitsused kaotati, tuli ka paikkonna tervisedendus ümber korraldada.

Maakonna üldiste arendustegevuste, rahvatervise, siseturvalisuse ja

kultuurivaldkonna kavandamine anti üle KOVidele (KOKS § 6¹), teostusvorm jäeti lahtiseks. Mõnes maakonnas hakkas maakonna arendusorganisatsiooni ülesandeid täitma omavalitsuste liit, teises arenduskeskus, Saaremaal ja Hiiumaal aga vallavalitsus. Osas maakondades on ülesanded jaotatud eri organisatsioonide vahel, nt vastutab kultuuri, tervisedenduse ja siseturvalisuse eest omavalitsusliit ning üldise arendustegevuse (sh maakonna arengukava) eest hoopis maakondlik arenduskeskus. Erinevalt on lahendatud ka personaliküsimus. On maakondi, kus nii siseturvalisust kui ka rahvatervist koordineerib üks spetsialist, teistes on jällegi kummagi valdkonna peale võetud eraldi inimene. Mõnikord täidab tervisedenduse spetsialist ka muid ülesandeid, nt viib läbi arendustegevust.

KOVide tervisedendust on reformid mõjutanud oluliselt vähem. Neil tuleb endiselt täita tervisealaste õigusaktidega pandud kohustusi ja viia ellu tervisedenduslike tegevusi (RTS § 10), kuigi vastava ametikoha loomise kohustust ei ole. Seetõttu ei olegi praegu enamikus KOVides tervisedendusspetsialisti ning tööloik on jagatud mitme töötaja vahel või jäetud sootuks tähelepanuta.

Reformiga kaasnenud võimalused ja raskused

Enamik maakondade tervise- ja turvalisuse spetsialiste tunneb, et võrreldes maavalitsuste ajaga on nad nüüd rohkem „pildis”. Neid kuulatakse rohkem, kaasatakse maakonna arengu planeerimisse ja aina enam ka mitmesugustesse aruteludesse, mis on oluline samm sisuka koostöö poole. On avanenud uued võimalused tervise ja heaolu edendamiseks: uued inimesed, uued juhid ning areenid teema üle arutlemiseks. Teistpidi on sulgunud palju seni pikka aega

avatud olnud uksi: mitmed kogenud spetsialistid on lahkunud, hästi toimunud koostöömudelid on lagunened. Kui maavalitsustes oli tervisedendajatel abiks tugistruktuur (IT abi, avalike suhete spetsialistid jne), siis enamikel maakondlikel arendusorganisatsioonidel praegu see puudub. See tähendab, et spetsialistid peavad tugiülesandeid ise täitma ja see võtab ära aega sisulistelt töölt. Mõnikord ei osata ka võimalusi ära kasutada, nt põhjendada tervisedendaja ametikoha loomist KOVis või maakondlikus arendusorganisatsioonis, toetudes töenduspõhisele infole, või kasutada tervise- ja heaoluprofiili alusmaterjalina maakondliku arengukava koostamisel.

Asjaolu, et paikkondlik tervisedendus on maakonniti korraldatud erinevalt, võimaldab küll valdkonna arengusse läheneda uutmoodi (nt laiendada koostööpartnerite ringi, katsetada uusi viise tegevuste elluviimiseks). Samas nõuab see Tervise Arengu Instituudilt, sotsiaalministeeriumil jt tervisedendust toetavatel organisatsioonidel pikemat ja laialdasemat tegevuste planeerimist, sest samad lahendused ei pruugi sobida kõigile.

Uus korraldus, kus KOV vastutab rahvatervise arengu eest nii kohalikul kui ka maakondlikul tasandil, loob head eeldused selleks, et valdkond saab „tema omaks”, mitte maavalitsuse südameasjaks, nagu see oli seni. See vähendab soovi vastutust delegeerida ning annab rahvatervise eestvedajatele selgemad ja jõulisemad argumendid KOVide nõustamiseks.

Omavalitsuste liitumislepingute alusel loodi mitmetes KOVides tervisedendajate ametikohad. Pädeva spetsialisti olemasolu loob eelduse, et valdkonda juhitakse strateegiliselt, arvestades ka külgnevate valdkondade plaane (transport, linnaplaneerimine, haridus, turvalisus, majandus

jne). Praeguseks on mõned 2018. aasta alguses loodud ametikohad omavalituste struktuurist kaotatud. Põhjuseid on mitmeid, kuid eelkõige näitab see seda, et omavalitsuste juhid alati ei mõista ennetustöö ja tervisedenduse tähtsust ega laiahaardelisust. Tervis ja heaolu jäävad sageli teisejärguliseks valdkonnaks, millega tegeletakse üksikürituste raames siis, kui raha jagub. Kuigi kõik KOVid panustavad rohkem või vähem tervise ja heaolu edendamisse (nt arendades transpordikorraldust, tagades elanikele teenuseid ja turvalisust), võib väita, et enamik neist ei tegele valdkonna arendamisega süsteemselt ja järjepidevalt.

Ootused omavalitsustele ja maakondlikele arendusorganisatsioonidele

Tervise Arengu Instituut ootab oma partneritelt paikkonna tervisedenduse arendamisel nelja peamist asja.

1) Suhtuge tervisedendus teiste valdkondadega võrdselt. Tervisealased eesmärgid peaksid kajastuma kohalikes arengukavades ja maakondlikes arengustrateegiates. Ka teiste valdkondade tegevusi planeerides tuleks alati analüüsida nende võimalikku mõju inimeste tervisele ja heaolule. Nimetatud dokumentide tegevuskavades loodame tervise alastes tegevustes näha selget ülesannete jaotust, vastutajaid ning keskendumist ühe või kahe põhiprobleemi lahendamisele.

2) Näidake, et te väärtustate oma inimeste tervist ja heaolu sellega, et tagate valdkonna arendamiseks vajaliku inimressursi. Hooolimata valdkonna laiahaardelisusest on süsteemi loomiseks ja haldamiseks vaja konkreetset inimest, kellel oleks võimalik

rahvatervise edendamisesse panustada täiskohaga. Peame parimaks lahenduseks, et ametikoht loodaks samasse üksusesse, mis vastab ka üldisemalt KOVi või maakonna arendustegevuste eest. See loob valdkondade üleseks planeerimiseks paremad eeldused. Ühtlasi lihtsustab spetsialisti tööd toetava ekspertrühma (tervisenõukogu, tervise meeskonna, valdkondliku tööruhma) loomine, mis toob ühe laua taha kokku eri valdkondade praktika ning teadmised.

3) Kui teie paikkonnas ei ole veel tervise- ja heaoluprofiili, siis kindlasti soovitame teil see koostada. See analüüs on prioriteetide seadmise ja tegevuste planeerimise alus ning annab mitmekülgse ülevaate paikkonna olukorrast (sh demograafilistest, majanduslikest, tervise-, turvalisuse, kultuuri jm näitajatest). Ainult asjakohastele andmetele tuginedes on võimalik ressursse otstarbekalt kasutada ning tegeleda oluliste probleemidega, mis vajavad paikkonnas lahendamist.

4) Algatege ja viige kavakindlalt elu tegevusi, mis aitavad luua paikkonnas tervist ja heaolu toetava elukeskkonna (kaasa arvatud vaimne ning sotsiaalne keskkond). Seejuures peaksid tegevused olema tõendus põhised ehk sellised, mille puhul on kindel, et need toovad oodatud positiivseid tulemusi ning neid tulemusi on võimalik ka hinnata. Näiteks ühekordseid spordi- või terviseüritusi ei peeta rahvusvahelise praktika alusel tõendus põhisteks. Veelgi enam, ühekordsed üritused sageli pigem suurendavad ebavõrdsust, kuna kohale tulevad inimesed, kes nagunii on harjunud liikuma, mitte need, kes on passiivsed ja vajaksid tuge või innustust. Aga just ebavõrdsuse vähendamine on põhimõte, millest tegevuste planeerimisel tuleks lähtuda üha enam. **S**